

23 - 02- Les tumeurs ovariennes (Audio) - Pr. HAROU

Tout d'abord bonjour, vu que vous avez avancé dans le cours de gynéco, je crois que tous les cours sont faits, presque, en gynéco, je parle de la gynéco, pas de l'obstétrique. Vous avez fait les concerts du sein, les concerts de l'endommagement, non pas encore ? Parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un cours de gynéco, donc on va faire ça, la dernière fois on avait fait le cours d'obstétrique, aujourd'hui on va parler des tumeurs de l'ovaire, c'est notre cours d'aujourd'hui, c'est de la pathologie tumorale, et donc vous savez l'ovaire est un organe très très important chez la femme, c'est un organe à la fois de la reproduction mais aussi un organe hormonal qui va permettre de produire des follicules qui vont donner par la suite des gamètes, mais aussi va permettre une sécrétion hormonale qui va maintenir le cycle féminin tout au long de la vie génitale jusqu'à la ménopause. Mais malheureusement cet organe peut aussi tomber malade et peut être siège de processus tumoraux.

Aujourd'hui on va parler des tumeurs de l'ovaire, ce qui l'oppose aux fameux kystes de l'ovaire, les kystes de l'ovaire c'est quelque chose de très fréquent chez les femmes, le plus souvent c'est des kystes fonctionnels, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas de la pathologie tumorale, c'est de la pathologie fonctionnelle. On va parler de la pathologie tumorale, c'est à dire quelque chose qui va persister, qui va ne être traité que par la chirurgie. On va voir que l'arme principale dans la prise en charge des tumeurs de l'ovaire, c'est la chirurgie.

Et donc dans ce cours, ça regroupe à la fois les tumeurs bénignes comme les tumeurs malignes. Toute tumeur de l'ovaire n'est pas une tumeur maligne. Lorsqu'il s'agit de femmes âgées, on ne va plus suspecter le cancer de l'ovaire, mais lorsqu'il s'agit de femmes jeunes, en général les tumeurs bénignes aussi sont très très fréquentes.

Donc, c'est des processus prolifératifs, les tumeurs c'est des processus prolifératifs qui peuvent être bénins ou malins. Elles peuvent être aussi kystiques. Les kystes de l'ovaire sont le plus souvent fonctionnels, mais il y a des fois des kystes qui sont malins.

Et on va voir qu'il y a des critères qui vont nous suspecter des kystes malins. Kystes plutôt organiques. Alors le contraire de fonctionnel, c'est organique.

Fonctionnel, ça va disparaître. Non fonctionnel, organique, ça va persister. Heureusement que la plupart des tumeurs sont bénignes et qu'aujourd'hui, on va voir l'arme principale, c'est la chirurgie pour les tumeurs bénignes, mais aussi associée à la chimiothérapie lorsqu'il s'agit du cancer de l'ovaire.

Un petit rappel sur l'ovaire, c'est ce petit organe, ce petit ovoïde qui présente à la surface. On va voir tout au long de cette surface les différents follicules, du petit follicule primordial jusqu'au corps jaune. Et puis, il y a cette partie centrale qui est, elle, la médulla, où on va trouver des cellules germinales, mais aussi des cellules de théca et de sertolie.

Et donc, les tumeurs peuvent être des processus prolifératifs à partir de tous les types de tissus. A la fois le tissu épithélial, et on parle de tumeur épithélial, à la fois de tumeurs au niveau de la modulaire et surtout ce sont des tumeurs endocrines, telles que les tumeurs de cellules de Lédig et Sertoli, ou ça peut provenir des cellules germinales ou des cellules thécales qui, elles, forment la périphérie du follicule. Et on va parler de tumeurs germinales, ou la tumeur thécale.

Et pour cela, il y a une classification, voilà, grosso modo, on va distinguer les tumeurs épithéliales, les tumeurs stromales, qui viennent du stroma, et les tumeurs germinales. Et on peut voir que les tumeurs stromales et germinales, c'est plus les patients jeunes et les tumeurs épithéliales, en général, c'est les femmes âgées. Et donc aujourd'hui, en détail, l'OMS offre une classification très détaillée de ces tumeurs.

Les tumeurs épithéliales, il y a plusieurs sous-types. Vous avez les tumeurs séreuses, les tumeurs mucineuses, endométriales, les tumeurs à cellules claires, ça c'est les plus fréquentes. Elles constituent 80% des tumeurs de l'ovaire, qu'elles soient bénignes ou malignes.

Donc ce sont les tumeurs épithéliales. Puis vous avez les autres tumeurs non-épithéliales qui correspondent à 20% de la pathologie tumorale, à savoir les deux grands groupes, les tumeurs germinales et les tumeurs des cordons sexuels stromogonadiques. Et puis vous avez aussi l'ovaire qui peut être un organe où certains cancers vont donner des métastases tels que les tumeurs digestifs.

Les tumeurs digestifs peuvent donner des métastases ovariennes, qu'elles soient les tumeurs du stomach, les tumeurs du colon ou les tumeurs du pancréas. Ça peut donner des métastases ovariennes. D'ailleurs, beaucoup de patients pour lesquels on fait une laparotomie pour les tumeurs bilatérales, en général c'est des tumeurs bilatérales, on va retrouver sur la laparotomie définitive que c'est des tumeurs secondaires et à ce moment-là il faut rechercher une origine primitive.

Parfois la tumeur est tellement petite au niveau de l'estomac et vous avez des métastases ovariennes avec des gros processus tumoraux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ovaire c'est un organe sécrétant, donc on peut avoir des tumeurs à différenciation sexuelle, c'est-à-dire sécrétant soit des oestrogènes et à ce moment-là on va les appeler tumeurs féminines ou féminisantes, ou là sécrétant de la testostérone et à ce moment-là on va les appeler tumeurs masculinisantes. À votre avis, quel est le symptôme clinique qu'elle va donner une tumeur féminisante ? Là ? La gynécomastie ? C'est des femmes.

Métrorragie, oui. Oui. Elles féminisent les femmes.

Féminisantes. Ah ben vous avez la puberté précoce. Si c'est des tumeurs qui vont survenir par exemple chez des petites filles, par exemple si vous avez une fille qui a 6 ans et qu'elle a ses règles, vous trouvez que c'est normal ? On peut avoir des tumeurs féminisantes aussi chez les

prépubères.

Et aussi la reprise du cycle après la ménopause, puisqu'après la ménopause il n'y a plus de sécrétion hormonale, ces tumeurs vont sécréter des oestrogènes et des femmes vont vous dire voilà après 3 ou 4 ans de ménopause mon cycle est revenu. C'est inquiétant. Et par contre les tumeurs masculinisantes, qu'est-ce que ça va donner ? Là ? La ménorrhée, oui.

Oui. Hein ? La virilisation, oui. Avec l'hirsutisme, l'acné, la voix qui change.

Donc c'est des tumeurs virilisantes. Tout à fait. Et vous avez aussi des tumeurs qui vont sécréter les deux.

Ça s'appelle les tumeurs, les gynandroblastomes. Ça va sécréter des oestrogènes et de la testo. Vous aurez un peu un mélange du charabia entre les deux.

Malheureusement ces tumeurs de l'ovaire lorsqu'elles sont malignes, elles vont le plus souvent être très agressives. Pourquoi ? Parce que vous voyez sur cette image là, les ovaires sont des organes intra-abdominaux libres. Donc dès que la tumeur sort de sa capsule, elle va diffuser les cellules.

Elle va les diffuser où ? Dans toute la cavité abdominopelvienne. Et donc vous aurez de la carcinose qui peut toucher le péritoine, tous les organes. Et en fait ça peut devenir, de partir d'une maladie d'organes vers une maladie de tout un compartiment.

Que ça soit pelvien ou abdominal, ça peut nécessiter parfois l'intervention de plusieurs spécialistes. Vous pouvez avoir une tumeur de l'ovaire avec de la carcinose pelvienne et une métastase ou de la carcinose au niveau de la rate, par exemple, au niveau du foie. Une double équipe entre la chirurgie viscérale et la chirurgie gynécologique.

Sur le plan moléculaire, par contre, c'est différent du plan anatomo-pathologique parce que sur le plan moléculaire, on va distinguer deux types. Vous aurez le type 1 et le type 2. Le type 2, c'est le plus fréquent, c'est 80%. En général, c'est ces fameuses tumeurs épithéliales, d'accord ? Mais en général, elles sont de haute grade.

Par contre, sur le type 1, c'est les mêmes tumeurs épithéliales. En fait, ce qui les différencie, c'est le bas grade. Vous voyez que les bas grades sont moins fréquents.

Les bas grades, ça veut dire que l'évolution et la multiplication tumorale, elle est très lente. Et les hauts grades, la multiplication tumorale, elle est rapide. Et vous avez d'autres types, les non séreux qui sont classés dans le type 1. Alors, les types 2 sont agressifs, mais l'avantage, c'est qu'ils sont sensibles à la chimie.

Les types 1 sont moins agressifs, mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont moins sensibles à la chimie. Vous voyez que l'un compense l'autre. Ça veut dire que les types 2, même s'ils sont

agressifs, quand on met avec la chimie, on peut carrément faire disparaître tous les implants tumoraux.

On peut retrouver une femme qui n'a rien. Il nous est arrivé d'opérer des patientes qui ont eu de la chimie non adjuvante pour cancer de l'ovaire. Après, on ne retrouve rien du tout.

Tout est stérilisé. Il nous arrive aussi d'opérer des femmes pour qui la chimie n'a rien fait. En général, c'est ces tumeurs de bas grades.

Je passe. Ça, c'est la physiopathologie. Alors, il faut savoir que c'est malheureusement la tumeur de l'ovaire.

Alors, vous allez voir que le cours est plus axé vers le cancer parce que l'objectif de tout médecin, c'est de ne pas méconnaître un cancer. Une tumeur de l'ovaire, même si je vous ai dit au début, les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes, mais la hantise, c'est de rater un cancer. Même si c'est moins fréquent que les tumeurs bénignes, la hantise, c'est de rater un cancer.

Pourquoi? Parce que le cancer de l'ovaire est un cancer mortel. C'est un cancer qui diffuse rapidement. C'est un cancer de mauvais pronostic.

Et donc, tout retard diagnostique va faire perdre les chances à la patiente. Vous avez certains facteurs qui vont prédisposer, bien sûr, à ces tumeurs de l'ovaire, tels que les facteurs hormonaux, avec l'annulipare, l'âge de grossesse tardif. Certains facteurs familiaux, lorsque vous trouvez qu'il y a dans la famille des cancers de l'ovaire, tels que le cancer du sein, du côlon, de l'ovaire, parfois, ça peut témoigner de mutations génétiques qui peuvent donner différents cancers dans différents membres de la famille.

Vous avez les fameuses mutations des grands gènes BRCA1, BRCA2, et vous avez le syndrome de Lynch. Et puis, vous avez les facteurs environnementaux classiques, tels que le tabac et l'irradiation. Comment ça se présente cliniquement? Malheureusement, le cancer de l'ovaire, comme on dit, c'est un tueur silencieux.

Lorsque vous avez une petite tumeur, la patiente ne va pas la sentir. Elle ne va la sentir que lorsqu'elle va entraîner des effets sur la clinique. Le syndrome, quand on parle de syndrome tumoral, vous voyez que le fait qu'une tumeur soit visible pour la patiente, pour qu'elle puisse consulter, pour avoir une masse abdominale ou l'abdominopelvienne, ça peut nécessiter du temps.

Et donc, en général, ça va être associé à de l'acide. On parle de syndrome tumoral acétique qui va donner des douleurs. Donc, elle va ne consulter que lorsqu'elle aura mal, elle va avoir un abdomen distendu, une augmentation du volume de l'abdomen d'une façon anormale.

Parfois, on avait dit métrorragie. Parfois, ça va être révélé par une altération de l'état général. Et puis, vous avez des signes de compression.

Une fois que la tumeur de l'ovaire va atteindre certaines dimensions, elle va comprimer les organes de voisinage, à savoir, va comprimer l'abdomen, le rectum et elle peut comprimer aussi les urtères. Les syndromes endocriniens, en général, vous avez ces signes-là dont on a parlé, les tumeurs féminisantes, les tumeurs virilisantes. Et parfois, lorsqu'on a de la chance, on va découvrir fortuitement au cours d'un bilan annuel, en faisant une échographie, se retrouver avec une tumeur de l'ovaire de 2 à 3 centimètres.

C'est extraordinaire lorsqu'on les découvre à ce stade parce que, en général, ça va permettre la guérison totale. Et lorsqu'il y a complication, malheureusement, parfois, vous avez des péritonites par rupture et dissimulation du liquide tumoral au niveau de la cavité abdominale. Parfois, vous avez des tumeurs infectées.

Donc, ça va se manifester par un abcès, un abcès de l'ovaire, etc. Mais lorsqu'on découvre ça au stade de complication, en général, les choses vont de pire en pire. Voilà.

Il y a des patientes qui consultent à ce stade. Elles vont soit cacher l'abdomen, soit croire qu'elle est enceinte, et puis cacher l'abdomen. Elles croient qu'en fait, c'est de l'obésité.

Parfois, on ne comprend pas pourquoi ces patientes vont venir à ce stade-là. Jusqu'à ce qu'elle ait une dysplasie, parfois. Et donc, on ne comprend pas.

Donc, l'examen gynécologique au cours d'un suivi est très important parce que, parfois, au toucher vaginal, lorsqu'on vous enseigne le toucher vaginal, on peut palper les annexes. Parce que s'il y a une tumeur, vous allez palper une masse latérotérine. Une masse latérotérine, ça peut être une tumeur de l'ovaire.

Ce n'est pas toujours la GU. Mais chez une femme ménopausée, par exemple, si vous palpez une masse latérotérine, parce que les ovaires sont tellement petits à la ménopause que vous ne palpez rien. Ils sont tellement petits.

Mais si vous palpez quelque chose, ce n'est pas normal chez la femme ménopausée. Donc, le toucher vaginal est très très important. Donc, vous voyez que la clinique, malheureusement, elle est tardive.

Elle est tardive. Et, en général, le diagnostic va être tardif et le pronostic va être mauvais. En cas de cancer, bien sûr.

Maintenant, le deuxième examen, une fois que vous avez fait votre examen clinique, le premier réflexe, c'est de faire une échographie. Parce que c'est l'échographie qui va vous orienter. Alors, au départ, on avait des choses un peu simples, comme ça.

On peut dire qu'il y a des critères de bénignité, des critères de malignité. Donc, vous voyez qu'il faut regarder la taille. L'origine est difficile parfois.

On ne sait pas si c'est des tumeurs tubaires entre la trompe et l'ovaire. C'est difficile. Mais on sait que les tumeurs de la trompe sont très rares.

Et donc, la plupart du temps, on va dire le mot. Quel mot on va utiliser? Voilà, une tumeur annexienne. Puisqu'on n'arrive pas à la rattacher à l'ovaire ou à la trompe.

Une tumeur annexienne droite ou à la gauche. On va rechercher la bilatéralité. On va chercher la paroi de cette tumeur.

Alors, la paroi, bien sûr, ne va être visible que si il y a une composante qui sticke, parce que ça va entraîner une interface acoustique. Donc, la paroi, est-ce qu'elle est épaisse? Est-ce qu'elle est fine? Est-ce qu'il y a des septèmes, des cloisons à l'intérieur de la composante qui sticke? Parce que la plupart des tumeurs, des tumeurs malignes, sont solido-qui sticke. Il y a une partie solide et une partie qui sticke.

Dans la partie qui sticke, vous allez trouver qu'il y a une paroi épaisse, qu'il y a des cloisons et qu'il y a aussi des papilles. Des papilles ou des végétations dites endo-qui sticke, parfois même exo-qui sticke. Mais il est plus facile de voir les endo-qui sticke, puisqu'il y a l'interface acoustique.

Et ces papilles, il faut voir leur projection, leur diamètre et leur projection, et leur vascularisation. Cherchez bien sur la site et cherchez si cette tumeur est très vascularisée. Si elle n'est pas vascularisée, c'est en faveur d'un processus qui est malin plutôt.

Donc, les signes de malignité, c'est le tumeur solido-qui sticke. Vous voyez, en général, elles sont comme ça. Partie qui sticke, partie solide avec des cloisons.

Vous voyez, là, il y en a trois. Épaisse et en général irrégulière. Une paroi aussi irrégulière.

Des végétations. Puis des végétations comme ça, endo-qui sticke. Peut-être aussi exo-qui sticke.

Le fait que ce soit bilatéral aussi. Et le fait qu'il y ait aussi de la vascularisation. Mais ça, c'est au niveau gynécologie, au niveau médecine générale, c'est très bien.

Vous voyez que la vie est simple, la vie est facile. Lorsque vous avez ça, vous cherchez ces signes, c'est rapide, c'est facile. Mais d'autre part, on a les radiologues.

Les radiologues, ils sont dans leur bureau, ils ne voient pas de malades, ils voient des clichés. Et donc, ils vont vouloir affiner leur travail par l'imagerie. Parce que nous, nous avons emprunté l'imagerie à la radiologie, au service de la clinique.

Mais les radiologues restent quand même des spécialistes de l'imagerie. Et donc, leur travail essentiel, c'est d'affiner cette imagerie. Et de corréliser cette imagerie avec le risque de bénignité ou le risque de malignité.

Et donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Pour développer une classification. Et on va la voir.

C'est la classification ORADS. Parce que comme le BIRAIDS du sein, ils ont développé l'ORADS pour l'ovaire. Et donc, de 1 à 5. 1, c'est un ovaire qui est normal.

5, c'est un haut risque. Le 4, c'est un risque intermédiaire. Le 3, c'est un bas risque.

Et le 2, c'est en faveur de la bénignité. Et ils vous donneront aussi, en fonction de cette classification. C'est bien parce que vous n'êtes pas obligé de la faire vous-même.

Elle vous est donnée par le radiologue. C'est comme le sein. ACR1, ACR2, vous savez ce qu'il faut faire.

Est-ce que vous regardez pourquoi il a classé ACR2, ACR3 ? En général, il vous facilite. Et ils vont prendre même cette condition médico-légale. Ils vont vous dire ORADS1, ORADS2 ou ORADS5.

S'ils vous disent ORADS2, vous avez même un langage à proposer à votre patiente. C'est-à-dire que lorsque c'est ORADS2, une lésion certainement bénigne. Vous avez moins d'un pour cent de vous tromper.

Lorsque vous avez un bas risque, c'est un ORADS3. Le risque est entre un et dix pour cent. Lorsque vous avez un ORADS4, le risque est entre dix et cinquante pour cent.

Et lorsque vous avez un ORADS5, c'est au-delà de cinquante pour cent. Vous voyez le risque de malignité en fonction de la classification. On va voir cette classification en détail.

Alors, qu'est-ce que c'est que l'ORADS1 ? L'ORADS1, vous voyez que c'est zéro pour cent de malignité. Zéro pour cent. Ce sont les fameuses images anécogènes qui représentent des follicules.

Ce sont les images typiques ici qui représentent un corps jaune. On peut reconnaître un corps jaune, reconnaître un follicule. Et ce sont ces images-là, aussi de corps jaune, un peu hémorragique, qu'il faut reconnaître.

Donc, vous voyez ici, beaucoup de gens vont prendre cette image-là, centrale, avec une hypervascularisation, pour une tumeur maligne. Alors que si c'est un ORADS1, c'est rien, rien faire. Laissez la patiente tranquille et reconstrôlez-la au bout d'un mois ou deux mois.

Et c'est bien, parce que ces images-là, comme ça, étoilées, irrégulières. Vous voyez, irrégulière hypervascularisation. Ce que je vous ai dit dans la réflexion ancienne, si vous le mettez sur ce cas-là, vous allez me dire, c'est malin.

Donc, je vais aller opérer. Parce que le problème de la classification de l'envers, si vous

suspectez d'humanité, il faut y aller, il faut opérer. Et donc, imaginez que vous opérez cette patiente, vous lui retirez son envers, et l'anapathe vous répond corps jaune.

Là-bas, vous allez être poursuivi. C'est médico-légal. Donc, c'est pour ça que c'est une affaire de spécialistes à faire très attention.

Donc, le RATS2, c'est probablement bénigne. Donc, moins d'un pour cent de risque de malignité. Vous avez les lésions kystiques simples.

On a parlé des kystes fonctionnels. Les kystes inuriculaires, en général, moins de 10 centimètres, mais avec des cloisons fines comme ça et incomplètes. Ça, ce n'est pas inquiétant.

C'est des kystes simples. Il faut les recontrôler. Si jamais ça persiste, oui, il faut les opérer.

Mais en général, on ne va pas être très inquiet. Par contre, le RATS2, vous aurez encore ces images-là. Regardez, ces images de kystes hémorragiques avec des cailloux de sang à l'intérieur aussi.

C'est bénign. Vous avez le fameux kyste dermoïde avec de la graisse ici. C'est bénign parce qu'on sait que c'est un dermoïde.

Vous avez les images de l'endométriium. C'est dans le cadre de l'endométriose. C'est bénign, on le sait, c'est bénign.

Alors que vous voyez que ça ou ça, avec des images irrégulières, on aurait préparé ça pour une tumeur maligne. Vous avez les kystes par envariant. C'est-à-dire, vous avez l'envers et vous avez un kyste à côté.

Les kystes d'inclusion péritoneales, surtout pour sa dérence. Et vous voyez les hydrosalpins, ce qui peut aussi prêter à confusion sur une image anexienne alors que c'est juste un hydrosalpin. Donc tout ça, c'est au RATS2.

Par contre, les RATS3, vous avez 1 à 10% de risque de malignité. C'est-à-dire lorsque la taille dépasse 10 cm. Lorsque vous avez une projection papillaire, mais moins de 3 mm.

Rappelez-vous de ces végétations. Ils vont même à la végétation pour voir si la végétation dépasse 3 mm ou pas. Les cloisons, leur nombre, bien sûr.

Et puis, vous avez cette composante solide homogène comme ça qui peut témoigner d'un fibrotécom. Mais ça, on a 1 à 10%. Ça ne nous permet pas de surveiller.

Au RATS3, on a 2 solutions. Lorsque c'est comme ça ou comme ça, je crois qu'il faut explorer. Pour les 2 premiers, il faut contrôler.

Par contre, le RATS4, ça ressemble au RATS3, mais avec plus de cloisons. Des cloisons

vascularisées, des projections papillaires multiples au lieu d'une. Leur projection dépasse les 3 mm.

Ou bien, cette composante solide dont on a parlé tout à l'heure est hypervascularisée. Et enfin, le 5, plus de 4 papilles. La vascularisation très importante au niveau des cloisons.

La vascularisation très importante en intra-ovarien, en intra-tumoral. Et puis, la composante solide qui dépasse les 80%. Et bien sûr, lorsqu'il y a de l'acide associé.

Bon, pour vous dire, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça. On ne peut pas vous demander, que ce soit pour un généraliste ou pour un spécialiste, un gynécologue, de faire la classification en RATS.

C'est pour ça que c'est un privilège des radiologues. Parce qu'ils vont, pour faire la classification en RATS, ils vont rester en face de leur écran tranquillement. Alors que nous, on va faire une consultation en 15 minutes.

Il faut rapidement décider s'il faut opérer ou pas. Donc, quand vous avez un doute, vous demandez une échographie chez un radiologue. Il va vous répondre en RATS.

Et si vous répondez en RATS, vous aurez le risque. Et si vous avez le risque, vous allez pouvoir proposer une attitude à votre patiente. C'est clair ? Voilà, c'est compliqué.

C'est compliqué. Ce n'est pas moi qui est compliqué. Ce sont les radiologues qui ont... On était bien avant le RATS.

On était bien. Mais pour vous dire, aussi, ça nous a simplifié la vie dans l'imagerie mammaire. Dans le sein, vous demandez même à un étudiant en première année, je crois qu'il va vous répondre.

ACR4, qu'est-ce que vous faites ? Vous explorez. Histologie. Vous avez besoin d'histologie.

ACR1, ACR2. Vous voyez ? Ça vous a facilité la vie. La même chose, il faut juste... Vous allez vous habituer avec la classification en RATS.

Maintenant, vous allez voir les nouveaux compte-rendus. Ils vont sortir avec le RATS de plus en plus. En tout cas, au CHU.

Qui est passé en radiologie ? Non ? Tout le monde ? Vous n'avez jamais vu le RATS ? Est-ce que vous êtes passé il y a... Trois ans ? Deux ans ? Hein ? Les tabacs de l'âge commencent à nous bombarder avec le RATS. C'est pour ça que j'ai préféré vous en parler, parce que moi aussi j'en parlais. Je connaissais cette classification, elle est ancienne.

Je la connaissais. Mais comme, en pratique, les radiologues ne l'utilisaient pas, je ne voulais pas encombrer les étudiants. Et là, vous êtes obligés de la connaître, parce que les compte-rendus

vont sortir avec le RATS.

Alors, qu'est-ce qu'on pourra demander encore, à part l'échographie ? On vous dit que l'échographie nous a fait tout. On n'a pas besoin... On peut demander des marqueurs tumoraux, qui ne vont plus pas servir au diagnostic, mais servir après à la surveillance. Le fameux CA125 pour les tumeurs vitériales, et les autres marqueurs tumoraux, par exemple le CA199 pour les tumeurs mycineuses, l'alpha-photoprotéine, l'HTG, l'EDH pour les tumeurs germinales.

Mais par contre, lorsqu'on veut opérer, une information qui ne nous est pas donnée par l'échographie est celle de l'extension et les rapports. L'extension et les rapports. Est-ce que cette tumeur a envahi la vicié ? Est-ce qu'elle a envoyé les tureuses ? Qu'est-ce qu'elle entraîne ? Est-ce qu'elle a entraîné l'atteinte gonglionnaire ? Est-ce qu'il y a de la carcinose péritoniale ? Donc la TDM est très importante.

Vous pouvez la coupler à l'IRM. En tout cas, la TDM est très très bonne en matière de bilan d'extension, avec une bonne sensibilité. Par contre, dans les atteintes gonglionnaires, elle n'est pas très bonne.

C'est pour ça qu'en général, en fonction des facteurs de risque, on va proposer le curage pour les tumeurs, en tout cas, des premiers stades lorsqu'il s'agit d'un cancer. Quelques images. En général, vous avez de l'acide, des implants, de la carcinose.

Vous voyez ici, au niveau de la rate, les plians, le mesentère. Et ça permettra aussi de voir un petit peu les bilans d'extension et de juger de l'opérabilité. Est-ce que cette maladie est opérable ou bien elle a une maladie diffuse pour laquelle il faut juste aller faire des biopsies et attendre la chimiothérapie avant d'opérer.

L'IRM aussi peut être très importante lorsque vous avez un doute, surtout par rapport à l'origine. Lorsque l'origine n'est pas très claire, on peut céder avec l'IRM. En général, l'échographie et la TDM sont largement suffisantes.

Le PET-scan, oui, parfois, lorsque vous avez des doutes. Mais clairement, la TDM est très bien. Lorsque vous avez de la carcinose, ce n'est pas la peine de vous demander un PET-scan.

C'est la carcinose, la carcinose. Le PET-scan ne va rien vous donner de plus. Parce qu'on sait que le PET-scan est évalué à plusieurs endroits, même chercher des métastases au niveau de l'os, au niveau du cerveau, etc.

Mais vous savez que le cancer de l'ovaire est un cancer qui a une évolution loco-régionale. Plus dans la cavité abdominale. Et donc, c'est pour ça que il faut aller regarder lorsqu'on a un doute.

Il ne faut pas demander un PET-scan. Il faut aller faire une scéioscopie pour regarder si les lésions sont là et l'étendue des lésions. Pour ça, il y a des scores, bien sûr, pour voir quels

organes sont atteints.

Et en fonction de la scéioscopie, on va décider d'opérer au pain. Parce qu'il faut savoir, quand on a un cancer, il faut faire une laparotomie. La scéiose n'est pas un standard pour l'instant.

Le standard, c'est faire une laparotomie. Parce qu'avec la scéiose, il y a un risque de dissimulation des cellules cancéreuses. Mais parfois, lorsqu'elles sont déjà dissimulées, on fait une biopsie pour confirmer et envoyer en chimiothérapie.

Vous voyez, il y a des classifications, on va regarder. Vous voyez que ça peut toucher tous les compartiments. Tous les compartiments.

Tous les compartiments. Ça, je passe. Tous les compartiments.

Le chirurgien, en général, c'est très spécialisé. Le chirurgien doit, au cours d'une scéioscopie, donner un compte-rendu détaillé pour l'oncologue afin de savoir quelles sont les parties qui sont envahies. Et lorsqu'on fera une chimio, on va réévaluer par la suite pour voir la réponse à la chimiothérapie.

Alors, les complications de ces tumeurs ovariennes. Les tumeurs, en général, malignes, elles risquent d'avoir une hémorragie, elles risquent de se remplir avec un tableau de péritonite. Elles peuvent donner une atterration d'état général dans le cadre de la nutrition.

Elles peuvent faire une compression et aussi un envahissement des organes de voisinage. Mais, en général, la torsion, elle est typiquement pour les tumeurs bénignes. Ce sont les tumeurs bénignes qui sont libres, qui sont mobiles, qui peuvent tordre l'ovaire.

Et, en général, il faut reconnaître un tableau de torsion. Un tableau de torsion, c'est en général des jeunes femmes avec des cystes bénins, en général, qui vont venir aux urgences pour nausées, vomissements, douleurs abdominales intenses avec une défense. Et vous allez palper, au toucher vaginal, une masse latérotorine qui est fixée.

Il faut opérer. C'est une urgence gynécologique. L'infection peut l'avoir, bien sûr.

Vous avez les tumeurs malignes qui peuvent s'infecter, mais aussi les tumeurs bénignes qui peuvent s'infecter. Comme je vous ai dit, la classification de l'étendue des lésions au cours d'un cancer de l'ovaire est basée sur la classification phygo et elle est basée sur la visualisation de la maladie, que ce soit par scéioscopie ou par la parotomie. La scéioscopie, c'est en cas de doute.

Lorsqu'on n'a pas de doute, lorsque le scanner est clair, lorsque le radiologue est clair sur la conclusion qu'on a une carcinose localisée avec un tumeur de l'ovaire et qu'on est sûr qu'on va aller opérer, ce n'est pas la peine de faire une scéioscopie. On va faire directement la parotomie, regarder un petit peu ce qui se passe et traiter la maladie. Lorsqu'on a un doute sur le fait d'opérer, il faut faire une scéioscopie avec biopsie si la maladie est inopérable et si la maladie

est inopérable, on convertit en la parotomie.

Quels sont les gestes maintenant qu'on peut proposer pour ces femmes ? Dites-moi. Exerès ovarien. À partir de quelle orate déjà vous allez commencer à agir ? 3. Vous voyez que même le 3 dans l'ovaire est un peu... parce que vous avez un risque de 1 à 10% même de malignité.

On va revenir à cette classification orate. Voilà. Par contre, en fonction de l'orate, dans ces deux premiers cas, vous voyez que ce n'est pas la même chose.

Ici, vous pouvez faire une anexectomie, mais là, en général, on va se contenter de quistectomie et attendre l'anapathie. Parce que c'est à cheval entre le 2 et le 3. Donc, la décision thérapeutique, elle ne dépend pas uniquement de l'orate. Elle dépend bien sûr de l'orate, mais aussi de l'âge de la patiente et du désir de grossesse et de la fertilité de cette patiente.

Est-ce qu'elle a des enfants ? Est-ce qu'elle n'a pas d'enfants ? Est-ce qu'elle est mariée ou pas ? Quel âge a-t-elle ? Plus la patiente est jeune, la règle est plus la patiente est jeune, on va privilégier un traitement conservateur. Le traitement conservateur, on va passer de la quistectomie première à l'anexectomie. Et toujours, lorsque l'on a des tumeurs probablement bénignes, on va aller faire une quistectomie.

Chaque fois qu'on a une femme jeune, mais avec un orate 4 ou 5, avec une suspicion forte de malignité, à ce moment-là, on va faire un traitement conservateur type anexectomie. Anexectomie. Déjà, l'anexectomie, c'est un traitement conservateur parce que le traitement standard quand il s'agit d'un cancer, c'est l'hystérectomie avec anexectomie bilatérale, puis homoantectomie et les restes des lésions qu'on retrouve sur l'abdomen.

Mais le traitement, l'anexectomie chez la femme jeune, en cas de cancer de l'obère, est considéré comme un traitement conservateur. Donc, la chirurgie est très importante et les opérateurs dépendants et l'expérience dépendante. Parce que l'expérience va permettre, en fonction de la visualisation des lésions, de décider en préopératoire.

Même si on part, on va décider une quistectomie chez la patiente. Lorsqu'on a un aspect inquiétant en préopératoire, ça peut se transformer en anexectomie. Parce que le problème du cancer de l'obère, si vous faites une quistectomie que c'est un cancer, vous allez disséminer le cancer.

Il faut ne faire que la quistectomie qui vous est sûre avec la classification en RATS, mais la classification en RATS n'est pas suffisante, parce que vous avez 1 à 10% dans le RATS 3, mais c'est 1 à 10%. Ça peut être 2%, ça peut être 3. Elle échappe avec la marge, parce que cette marge va être réglée en fonction des données opératoires. En opération, on peut dire oui, on est plus sur les 10%, on est sur les 1%.

Donc le 3 va vraiment nous poser un problème. Comme dans le 5, il y a toujours un stade

intermédiaire qui va poser problème. Et donc l'ovariectomie, c'est une option aussi, l'anexectomie aussi, mais comme je vous ai dit, si la patiente n'a pas d'enfant, elle est jeune, la décision est très difficile.

Mais par contre, la patiente âgée, avec des enfants, qui a déjà un projet de maternité, la décision va être plus facile. Et le traitement standard en cas de cancer de l'ovaire, c'est la chirurgie radicale, c'est l'hystérectomie totale, avec anexectomie, homoantectomie, plus ou moins, les curages pelvien et l'emboi uratique. Et bien sûr, des gestes autres, tels que les exercices digestifs.

Donc la laparotomie est le standard lorsque vous avez une substance de maladie. Par contre, dans les ORATS 2, on avait dit que c'est des tumeurs bénignes. ORATS 1, c'est un ovaire normal, on n'opère pas.

Le 2, c'est des tumeurs bénignes, donc c'est en général le traitement conservateur, c'est-à-dire l'achystectomie par celluloscopie. Donc celui qui va nous poser problème, c'est toujours le 3. Le 3 nécessite de l'expertise. Vous voyez des images d'une chirurgie de cancer de l'ovaire, ça peut être très délaborant.

Hystélectomie, anexectomie bilatérale, curage ganglionnaire, avec un curage lombo-urtique, parce qu'on sait que l'ovaire peut donner des gonglions, des adénopathies lombo-urtiques, en mantectomie, peut parfois enlever carrément des gros morceaux d'intestin. Et le but, c'est de ne pas laisser de la maladie macroscopique. Alors, macroscopique, parce que il y aurait toujours de la maladie macroscopique, mais le but en tout cas pour la chirurgie, c'est la maladie macroscopique.

C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé à guérir le cancer de l'ovaire. Cette histoire de maladie macroscopique ne veut rien dire. C'est ce que les chirurgiens voient.

Mais on sait que en général, il y a toujours de la maladie, c'est diffusé, il y a toujours de la maladie. Et en général, c'est des récides dans le futur, assez proches. Mais dans tous les cas, actuellement, c'est ce qu'on sait faire.

Il y a beaucoup de développement, surtout en matière médicale. Je crois que le cancer de l'ovaire va être vaincu grâce à l'oncologie, pas grâce à la chirurgie, parce que ça fait 100 ans qu'on fait de la chirurgie et on n'est pas encore arrivé à guérir le cancer de l'ovaire. Et donc, probablement, c'est la chimiothérapie, c'est les thérapies ciblées.

La chimiothérapie, en général, c'est des protocoles avec de la carboplatine ou la cisplatine avec les taxoles. Mais vous avez aussi aujourd'hui des thérapies ciblées. Il y a tellement de choses qui se développent.

L'oncologie est une spécialité très prometteuse. Il y a beaucoup de cancers qui vont être guéris

rien que par des traitements médicaux. Donc, si on veut résumer le traitement tumeur bénigne, sédorado 2, traitement conservateur, sauf chez la femme âgée, alors la femme âgée, pour ne pas revenir, c'est assez simple, mais on peut retirer cette phrase aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on faisait avant.

On disait femme âgée, ménopausée, on fait là l'hystérectomie, ben on fait l'hystérectomie, puisqu'on y est, on enlève tout. Mais ce langage, aujourd'hui, je crois qu'il faut le nuancer, parce que plus on fait des gestes agressifs, invasifs pour la patiente, plus on risque des complications. Une anexectomie, vous avez moins de risques de complications qu'une hystérectomie.

Vous voulez faire une anexectomie, vous voulez dire dans la foulée d'une hystérectomie, vous faites un problème, une lésion urétérale, le CADA, vous allez vous retrouver dans un problème. Donc, il ne faut pas surtraiter les patients. Il faut juste traiter les patients.

Par contre, pour les tumeurs malignes, à chaque fois qu'on est devant une nullipare, une jeune femme, une anexectomie, et puis pour tout le reste, c'est le traitement radical. Le traitement radical veut dire hystérectomie avec curage, et toujours chimiothérapie. Alors la chimiothérapie peut être de néoadjuvante ou d'adjuvante.

Si la tumeur est opérable, elle va être adjuvante. Si la tumeur est inopérable, elle va être néoadjuvante. C'est-à-dire qu'on va commencer par la chimiothérapie, et on va faire la chirurgie par la suite.

Aujourd'hui, les facteurs pronostiques, on le sait, c'est premièrement l'âge, le volume de ce que vous allez laisser, de la maladie, parce que parfois on ne peut pas enlever tout. Surtout lorsque ça devient dangereux. N'oubliez pas que ce sont des femmes âgées, altérées, patients de 75 ans ou de 78 ans, que vous allez opérer.

La moyenne de survie de cette patiente, vous n'allez pas encore l'aggraver avec votre chirurgie, elle mourra dans six mois. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'âge et les tares, bien sûr, et l'état général. Ça, c'est important.

Et bien sûr, la stade de la maladie et le grade histologique. On avait dit que les types 1 et 2, les types 2, sont plus agressifs que les types 1, et les types 2 sont plus chimiosensibles que les types 1. Les chimiosensibles, ça ne veut pas dire qu'ils vont guérir. Ça veut dire qu'ils vont répandre la différence.

Mais en général, ils rechutent rapidement. Ça, c'est une revue de littérature avec plusieurs études. En fait, il y a un grand débat dans le concert de l'OVR.

Il y a des partisans pour la chirurgie, d'emblée, qui sont peu nombreux dans le monde. Il y a des partisans pour faire un chimio à la chirurgie. Et on est venu comparer les deux.

Est-ce que le chimio fait mieux avant ou après? Aujourd'hui, ils sont équivalents lorsqu'il s'agit

d'une tumeur opérable. Même pour les tumeurs opérables avec maladies diffuses, il y a des gens qui vont dire « je préfère faire de la chimio, faire qu'une stérectomie et une anexectomie, que d'aller faire une chirurgie première, enlever le collant, enlever la rate, enlever plein de choses. Ça va plus de morbidité et sur la qualité de vie.

Aujourd'hui, c'est comparable. Par exemple, dans le service, notre attitude est de faire une chimio première lorsqu'il s'agit d'une carcinose diffuse. Même si la tumeur est opérable, ça nous permet de faire de moins de gestes invasifs sur la patiente en post-chimio.

Lorsqu'on part pour une chirurgie première, on est très agressif. Et en général, on risque de perdre les patientes, pas par la chirurgie, mais par les complications de la chirurgie. Patiente diabétique, hyper tendue, obèse, malnutrie, vous vous opérez, vous allez la déstabiliser.

Donc, en général, on privilégie chaque fois qu'il y a une maladie la chimiothérapie. Vous voyez que le pronostic est bon lorsqu'il s'agit de stade débutant, mais malheureusement il est mauvais dans les stades 4 ou les stades 3. Malheureusement, la plupart des stades vont être découverts au stade 3 ou 4. La plupart des cancers de l'ovaire, c'est très rare qu'on ait des stades 1 ou 2 et donc la mortalité, le pronostic est très mauvais. Comment on fait une surveillance? Comme je vous ai dit, les marqueurs tumoraux au départ vont servir, pas de diagnostic, mais de surveillance.

Le CA125 est un tumor épithélial. Vous pouvez le demander une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans lorsque vous avez stabilisé la maladie. On peut demander une échographie au moins une fois par an pour chercher l'éventuel récidivé.

Sachez que ce sont des cancers qui peuvent récidiver très très rapidement. Pour conclure, vous avez vu que le tumor de l'ovaire, c'est des pathologies diverses, mais j'ai insisté sur le cancer parce que c'est la hantise du clinicien, c'est de passer à côté d'un cancer parce que les tumeurs bénignes, c'est la cerise sur le gâteau. Les tumeurs bénignes en général, ce sont des traitements simples, c'est une chirurgie avec histectomie.

Le problème va se poser lorsque vous avez un cancer, surtout chez les femmes âgées, dénutrées, fatiguées, altérées, parce que c'est un mauvais pronostic malheureusement. Aujourd'hui, le gold standard, c'est la chirurgie, et ce gold standard peut être la chirurgie. Aujourd'hui, le gold standard va plus vers chimio-adjuvant à la chirurgie, et dans l'avenir, ça pourra changer.

Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?